PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MÉDICA EN CASO DE DEFUNCIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA

1. OBJETIVO

El objetivo de este protocolo es la mejora en la asistencia en caso de fallecimiento, estableciendo unas pautas de actuación ante determinadas situaciones, que ayude a los profesionales sanitarios en su deber profesional de la certificación de la muerte, así como humanizar la atención, evitando la penosidad añadida a los familiares o allegados del fallecido.

2. MARCO NORMATIVO

- Ley del Registro Civil.

  - El Capítulo Tercero de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil recoge la inscripción de la defunción y en su artículo 66 sobre Certificado Médico de Defunción, en redacción dada mediante Ley 19/2015, de 13 de julio dice:

    "En ningún caso podrá efectuarse la inscripción de defunción sin que se haya presentado ante el Registro Civil el certificado médico de defunción. En el certificado, además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, deberán recogerse aquellas que se precisen a los fines del Instituto Nacional de Estadística y, en todo caso, la existencia o no de indicios de muerte violenta y, en su caso, la incoación o no de diligencias judiciales por el fallecimiento si le fueran conocidas o cualquier motivo por el que, a juicio del facultativo, no deba expedirse la licencia de enterramiento.

Las circunstancias mencionadas en el segundo inciso del párrafo anterior no serán incorporadas a la inscripción de defunción ni serán objeto del régimen de publicidad establecido en esta Ley, siendo su única finalidad la establecida en este artículo."

- Reglamento del Registro Civil. Decreto del 14 de noviembre de 1958 (Actualización en el BOE de 19 de septiembre de 1986).

  - El artículo 274 del Reglamento del Registro Civil dice:
    "El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad o cualquier otro que reconozca el cadáver enviará inmediatamente al Registro el parte de defunción en el que, además del nombre, apellidos, carácter y número de colegiación del que lo suscriba, constará que existen señales inequívocas de muerte, su causa y, con la precisión que la inscripción requiere, fecha, hora y lugar de fallecimiento y menciones de identidad del difunto, indicando si es conocido de ciencia propia y acreditada y, en este supuesto, documentos oficiales examinados o menciones de identidad de persona que afirme los datos, la cual también firmará el parte.
    Si hubiera indicios de muerte violenta se comunicará urgente y especialmente al Encargado."

- Código Civil.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  - En la Ley de Enjuiciamiento Criminal Art. 343 establece que:
    "los sumarios a los que se refiere el artículo 340 (muerte violenta o sospechosa de criminalidad) aun cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por los Médicos Forenses, o en su caso por los que el Juez designe, los cuales, después de describir exactamente dicha operación, informarán sobre el origen del fallecimiento y sus circunstancias."

- Reglamento del Consejo General de Colegios oficiales de Médicos.

- Código de Deontología Médica de la OMC 2022.

  - El Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial, en el artículo 38.6 recoge:

"Aunque el médico que haya tenido la mayor carga asistencial sobre el paciente es el que tiene la mayor responsabilidad ética de cumplimentar el certificado de defunción en todos sus apartados, no es deontológicamente aceptable rehuir el compromiso de certificarla cuando se produce habiendo presenciado el fallecimiento, reconociendo al paciente fallecido o teniendo a disposición la historia clínica."

- Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Decreto 2.263/74, de 20 de julio así como, a nivel de la CARM, la ORDEN, de 7 de junio 1991, de la Consejería de Sanidad, por la que se dictan normas sobre Policía Sanitaria Mortuoria (BORM 14 Junio 1991).
- Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria (aprobada en Comisión de Salud Pública de 24 julio de 2018).
- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

  - *La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de los profesionales sanitarios, en su Artículo 4: Principios generales, recoge:*

"7. El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico, y de acuerdo con los siguientes principios:

c) La eficacia organizativa de los servicios, secciones y equipos, o unidades asistenciales equivalentes sea cual sea su denominación, requerirá la existencia escrita de normas de funcionamiento interno y la definición de objetivos y funciones tanto generales como específicas para cada miembro del mismo, así como la cumplimentación por parte de los profesionales de la documentación asistencial, informativa o estadística que determine el centro."

3. TIPOS DE MUERTE

3.1. MUERTE SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD.

La muerte sospechosa de criminalidad es imprevista, sin antecedentes patológicos que la expliquen, bajo el signo de sospecha o duda que precisa de una investigación judicial para esclarecer la posible intervención de un elemento externo.

3.2. MUERTE VIOLENTA.

La muerte violenta es consecuencia de un elemento externo, se suele acompañar de lesiones o signos externos de violencia y precisa investigación judicial. Por su origen, se subdivide en muerte violenta accidental, homicida o suicida.

3.3. MUERTE NATURAL.

La muerte natural es el resultado final de una enfermedad en la que se descartan fuerzas extrañas al organismo del fallecido. No hay responsabilidad de terceros ni se derivan implicaciones de investigación judicial.

Dependiendo de la rapidez que llega el desenlace final hablamos de:

- **Muerte natural** como final de enfermedad cuando se produce tras un período variable de enfermedad.
- **Muerte repentina** cuando tiene lugar de forma inesperada en un breve espacio de tiempo, pero explicable a la luz de los antecedentes médicos del sujeto (no entraría la muerte súbita pediátrica o del adulto).

3.4. OTRAS MUERTES QUE PRECISAN INVESTIGACIÓN JUDICIAL:

La muerte súbita de lactante o adulto es una muerte inesperada que ocurre en un sujeto sin antecedentes patológicos que la hagan previsible, necesitando investigación judicial.

Otros ejemplos:

a. Cadáver no identificado.
b. Cadáver no reciente.
c. Cadáver sin documentación clínica o información insuficiente.
d. Muerte inesperada de un trabajador en el desempeño de su actividad laboral.
e. Persona privada de libertad o custodiada, incluidos enfermos mentales o discapacitados ingresados.
f. Aquella en la que se pudiera derivar una responsabilidad médica.

4. SIGNOS DE MUERTE Y TANATOCRONOLOGÍA.

4.1. Signos negativos de vida:

- No latido espontáneo. En la exploración apreciamos ausencia de pulso arterial y de auscultación cardíaca.
- No respiración espontánea. En la exploración hay ausencia de movimientos torácicos y de auscultación pulmonar.
- Midriasis bilateral arreactiva.
- Reflejo corneal ausente.

4.2. Signos positivos de muerte:

- Algor mortis. Enfriamiento progresivo desde las extremidades hasta los órganos internos. Según la estimación de Simpson, en las 6 primeras horas la temperatura esperable del cadáver es de 30-34° C, a las 10 h. de 28° C, y a las 15 h. de 24-26° C.

- Rigor mortis. Rigidez cadavérica, empieza en párpados y músculos facialesa los 30 minutos, se manifiesta de manera evidente a partir de las 3-4 h. En tronco y extremidades aparece a las 7-9 h., y es completa a 12-18 h. A partir de las 24-36 h. el rigor mortis desaparece en el mismo orden.

- Livor mortis. Presencia de livideces (manchas de coloración rosada o violácea) que aparecen en las partes declives del cadáver y por tanto dependen de la posición del cuerpo al morir. Se pueden apreciar aproximadamente a los 45 minutos tras la muerte, confluyen a partir de las 2 h. y se generalizan a las 12 h.

- Deshidratación corneal y hundimiento del globo ocular. Se manifiesta en una opacificación de la córnea, a partir de la primera hora y es debida a una evaporación de los líquidos intraoculares. Puede aparecer una manchade color negro a nivel de la parte externa del globo ocular y visible en la esclerótica llamada signo de Sommer-Larcher.

- Putrefacción. Son signos tardíos de muerte y se inician con la presencia de la denominada mancha verde que aparece a partir de las 24 horas de ocurrida la muerte y se localiza a nivel de la zona inguinal derecha.

5. ACTUACIÓN ANTE LOS DISTINTOS TIPOS DE MUERTE

En primer lugar, será preciso proceder a la comprobación de la muerte de forma obligatoria mediante:

- **Inspección externa del cadáver**. Valorar signos de muerte y pruebas complementarias como tira de ritmo ECG que confirmen el exitus.
- **Antecedentes patológicos y síntomas previos a la muerte**.
- **Valoración del entorno en el que se desarrolla el evento.**
- **Edad del fallecido.**

El equipo médico asistencial si lo considera necesario podrá ponerse en contacto con el médico forense de guardia a través del CCU, para aquellos casos en los que exista duda en el modo de proceder (todo quedará reflejado en la historia clínica).

Así mismo, podrá requerir la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado para valorar la existencia de posibles elementos extramédicos sospechosos de criminalidad.

Tras valorar lo anterior, delimitaremos si existen o no indicios de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.

5.1. MUERTE SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD.

En toda muerte sospechosa de criminalidad, el facultativo que asiste al difunto deberá:

- Cumplimentar la historia clínica.
- Cumplimentar el parte judicial.
- Dar parte al Juzgado de Guardia a través del CCU.
- Custodiar el cadáver hasta la llegada de las Fuerzas de Seguridad que puedan seguir con dicha custodia.

5.2. MUERTE VIOLENTA.

En toda muerte violenta, el facultativo que asiste al difunto deberá:

- Cumplimentar la historia clínica.
- Cumplimentar el parte judicial.
- Avisar al Juzgado de Guardia a través del CCU.
- Custodiar el cadáver hasta la llegada de las Fuerzas de Seguridad que puedan seguir con dicha custodia.

5.3. MUERTE NATURAL.

a. MEDIO HOSPITALARIO.

El médico del Servicio correspondiente, conforme a las normas de funcionamiento interno establecidas, emitirá el certificado de defunción.

b. RESIDENCIA GERIÁTRICA.

Si la muerte se produce en horario de presencia o disponibilidad del médico adscrito a la misma, será éste el que emitirá el certificado de defunción.

En caso de imposibilidad de dicha presencia o disponibilidad, será un médico de los servicios públicos de salud, al que corresponderá rellenar el certificado de defunción.

c. DOMICILIO PARTICULAR-VÍA PÚBLICA.

Tras confirmar el fallecimiento y si es posible, en horario lunes a viernes de ocho a tres se contactará con su médico de Atención Primaria o el médico de Atención Primaria que en ese momento esté de guardia, al que se le remitirá el informe asistencial del 061 para que cumplimente el certificado de defunción, en dicho informe constará de manera clara que no hay indicios de criminalidad.

Si no es posible el contacto con el médico de Atención Primaria, por motivos de festividades o situaciones análogas, el certificado se cumplimentará por el médico que ha confirmado la muerte (médico de Urgencias o Emergencias, ya sea del 061 u otros como PAC).

Se establecerá como norma general, que entre las tres de la tarde y las ocho de la mañana de lunes a viernes, y sábados, domingos y festivos las 24 horas, ante la imposibilidad de contactar con el médico de Atención Primaria y para facilitar el traslado del difunto, el certificado se cumplimentará por el médico que ha confirmado la muerte (médico de Urgencias o Emergencias, ya sea del 061 u otros como PAC).

Cuando por normativa legal aplicable se requiera el Certificado de Defunción para la retirada de la persona fallecida, si no se puede contactar con el médico de Atención Primaria, será el médico que ha confirmado la muerte (médico de Urgencias o Emergencias, ya sea del 061 u otros como PAC) quien cumplimentará el Certificado de Defunción.

Para cumplimentar el certificado de defunción se usarán los medios disponibles:

- Información aportada por los familiares o allegados.
- informes médicos previos o por los sistemas de información propios del SMS (Agoraplus, OMISure, …).

La comunicación de la defunción al Centro de Salud o Servicios de Urgencias-Emergencias extrahospitalarios se realizará por:

- Los familiares o allegados del fallecido asesorados por la empresa funeraria.
- Centro Coordinador de Urgencias (necesario un teléfono de contacto efectivo del Centro de Salud).
- Fuerzas de Seguridad si hubiesen intervenido.

Ante la muerte de un paciente de edad avanzada donde no haya evidencia de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y no existan antecedentes clínicos, se procederá a firmar el certificado de defunción indicando, si procede, "muerte de etiología natural de causa no determinada".

La muerte de una persona en vía pública en ausencia de testigos, aun cuando no se aprecien signos de violencia, se convierte en muerte sospechosa de criminalidad y, en consecuencia, se obrará de acuerdo con ese tipo de muerte.

5.4. OTROS TIPOS DE MUERTE QUE PRECISAN INVESTIGACIÓN JUDICIAL (muerte súbita, cadáver no identificado,…).

En todos estos casos, el facultativo que asiste al difunto deberá:

- Cumplimentar la historia clínica, refiriendo explícitamente los datos en los que se fundamenta la exclusión de emitir el Certificado de Defunción.
- Cumplimentar el parte judicial.
- Avisar al Juzgado de Guardia a través del CCU.
- Custodiar el cadáver hasta la llegada de las Fuerzas de Seguridad que puedan seguir con dicha custodia.

6. CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN (CMD) (ANEXO 1)

Documento jurídico-administrativo necesario para obtener la licencia de enterramiento, en el caso de muerte natural, y su finalidad es generar las estadísticas de mortalidad en España.

Está reservado a los nacidos vivos fallecidos de muerte no violenta o sospechosa de criminalidad.

Este documento sigue el modelo internacional de Certificado Médico de la OMS.

a. **En primer lugar**, hay que cumplimentar los datos administrativos:

OMC ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA | CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS

CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN

https://certificados.cgcom.es
EDLLLTO5ZA
Id. Electrónico

Colegio de

036353508
Nº Certificado

CLASE 3ª SERIE A

D. / Dña.
en Medicina y Cirugía, colegiado/a en , con el número
y con ejercicio profesional en

CERTIFICO la defunción de
Nombre del fallecido/a:
1er Apellido del fallecido/a:
2º Apellido del fallecido/a:
Fecha de nacimiento Día Mes Año Sexo: Varón Mujer
Documento de identidad: D.N.I. Número:
Pasaporte Número:
N.I.E. (Tarjeta de Residencia) Número:
Hora y fecha de la defunción Hora : minutos : Día Mes Año
¿En qué municipio ocurrió la defunción?:
Domicilio particular Centro hospitalario Residencia socio-sanitaria Lugar de trabajo Otro lugar

3,63 Euros. Derechos autorizados, I.V.A. incluido

- <u>Identificación del médico emisor del certificado.</u>

- <u>Identificación del fallecido.</u>

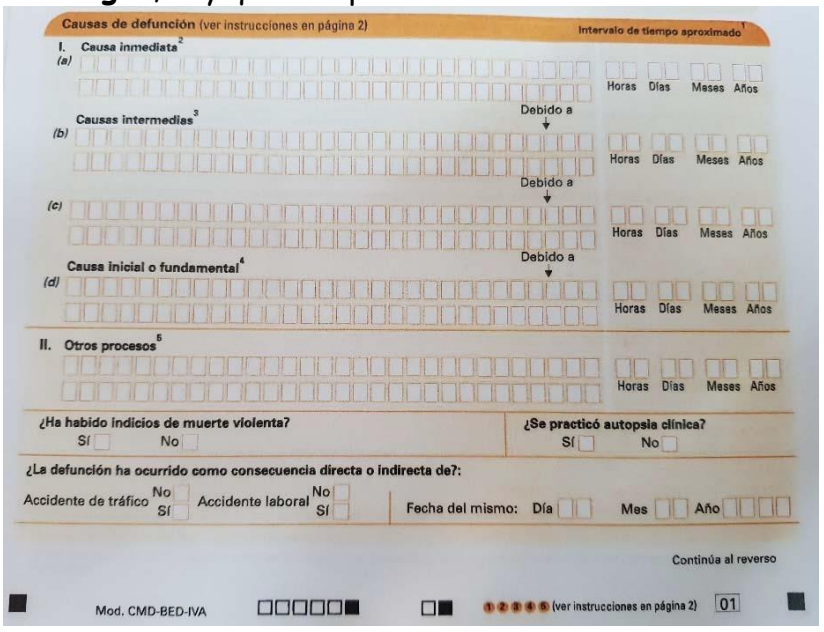
  - A través de DNI, pasaporte o tarjeta de residencia de forma preferente.
  - Pero también se puede hacer de ciencia propia (el facultativo lo conoce de forma directa).
  - Por mención de identidad (persona que indica los datos del fallecido y que también firmará el certificado de defunción).

  En caso de no poder identificar al cadáver, el facultativo no podrá cumplimentar el CMD, sino que deberá poner el hecho en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con toda la información de que disponga, y esperar la respuesta de la autoridad.

- <u>La hora y fecha de defunción.</u> La hora de la muerte marca el plazo legal de entierro, inhumación o incineración del cadáver. El médico da fe de la veracidad de las circunstancias de la muerte. Recordemos que modificar los datos a conveniencia de la familia podría ser un delito de falsedad de un documento público.

- <u>Lugar de la defunción</u>: municipio donde ha ocurrido la defunción.

b. **En segundo lugar**, hay que cumplimentar las causas de la defunción:


Causas de defunción (ver instrucciones en página 2)
Intervalo de tiempo aproximado[1]
I. Causa inmediata[2]
(a)
Horas Días Meses Años
Debido a
Causas intermedias[3]
(b)
Horas Días Meses Años
Debido a
(c)
Horas Días Meses Años
Debido a
Causa inicial o fundamental[4]
(d)
Horas Días Meses Años
II. Otros procesos[5]
Horas Días Meses Años
¿Ha habido indicios de muerte violenta?
Sí No
¿Se practicó autopsia clínica?
Sí No
¿La defunción ha ocurrido como consecuencia directa o indirecta de?:
Accidente de tráfico No Sí
Accidente laboral No Sí
Fecha del mismo: Día Mes Año
Continúa al reverso
Mod. CMD-BED-IVA
(ver instrucciones en página 2)
01

La OMS recomienda que en la cumplimentación de las causas de defunción se comience por la causa Inmediata y a continuación las causas intermedias, si existiesen, consignándose en último lugar la causa inicial o fundamental (causa intermedia originaria de la cadena causal), es decir, en un orden natural de arriba hacia abajo, respondiendo a las palabras "debido a" que facilitan la comprensión del concepto de secuencia lógica.

Nótese que las dos líneas de cuadros previstas para cada apartado deben considerarse como una sola y no para establecer orden de causalidad.

- <u>Causa inmediata.</u>
-
    - Anotar la enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente.
    - No se trata de indicar las modalidades de la muerte, sino la enfermedad, el traumatismo o la complicación causante del fallecimiento.
    - Es único.

- Causa intermedia.

    - Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba indicada.
    - Lógicamente, no tienen por qué existir siempre.
    - Si el estado patológico señalado en la línea causa inmediata fue consecuencia de uno o más estados morbosos, se anotarán en la línea (b) o en las líneas (b) y (c).
    - Las Causas intermedias, no se refieren a episodios o procesos previos que el paciente haya tenido. Son parte de Otros Procesos como veremos luego.

- Causa inicial o fundamental.

    - Enfermedad o lesión que inició los hechos anteriormente mencionados que condujeron a la muerte.
    - Se recomienda anotar una única causa, la que según el criterio del médico, haya sido desencadenante de todo el proceso que ha llevado a la defunción.

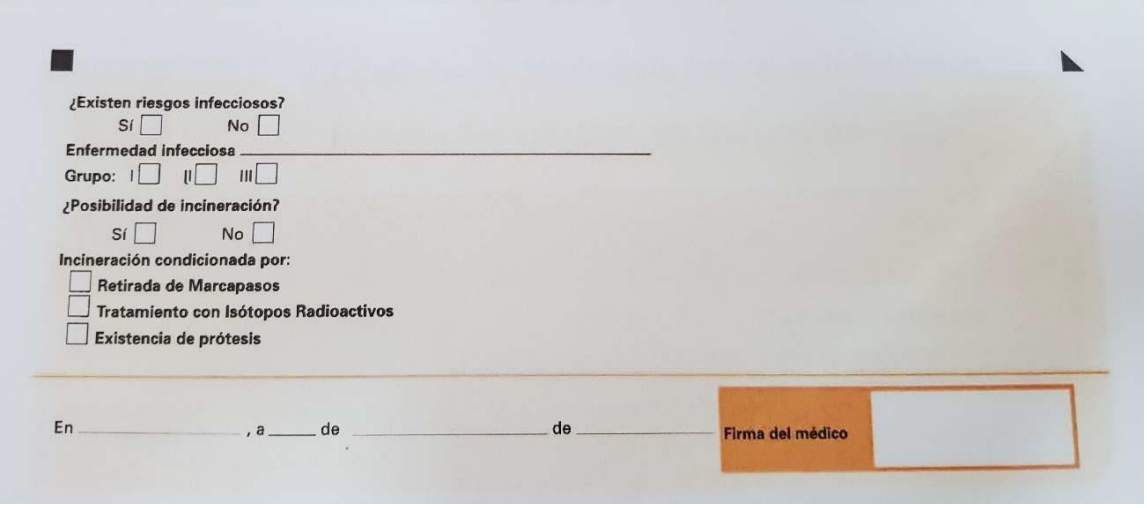
- Otros procesos.
-

    - Aquí se anotarán, por orden de importancia, todas las demás enfermedades o condiciones de las que se suponga han ejercido una influencia desfavorable en el curso del proceso patológico, contribuyendo así al desenlace fatal, pero que no guardan relación con la enfermedad o condición que causó directamente la muerte.
    - Si considera que debe anotar más de una enfermedad o condición, sepárelas claramente por comas.

- Intervalo de tiempo.

  - Se debe anotar el intervalo aproximado (horas o días o meses o años) entre el comienzo de cada afección y la fecha de la defunción.
  - Esta anotación proporciona ayuda al médico sobre la secuencia de acontecimientos que condujeron a la muerte, de tal forma que el tiempo anotado en el apartado I.(a) debe ser inferior o igual al I.(b), y este a su vez inferior o igual al I.(c) y así sucesivamente.
  - Sólo se debe poner si se conocen.
  - Estas unidades son mutuamente excluyentes, es decir, hay que expresar el periodo en una única unidad de tiempo y tan solo hay que rellenar una por proceso y línea.
    - Por ejemplo, para poner mes y medio pondríamos 45 días, nunca 1 mes 15 días.
  - Si hubiera que anotar más de un proceso en una línea, como estos deben informarse por orden de importancia en la secuencia, el intervalo de tiempo debe recoger el correspondiente a ese primer proceso informado.
  - Nota: Cada unidad de tiempo admite hasta el número 99

c. **Por último,** riesgo infeccioso, posibilidad de incineración, fecha y firma.



¿Existen riesgos infecciosos?
Sí ☐ No ☐
Enfermedad infecciosa _____
Grupo: I ☐ II ☐ III ☐
¿Posibilidad de incineración?
Sí ☐ No ☐
Incineración condicionada por:
☐ Retirada de Marcapasos
☐ Tratamiento con Isótopos Radioactivos
☐ Existencia de prótesis

En _____, a _____ de _____ de _____ Firma del médico

- En caso de existir riesgo infeccioso hay que rellenar la casilla correspondiente y especificar la enfermedad infecciosa.

  - Según la Guía de Consenso de Sanidad Mortuoria, los cadáveres se clasifican en tres grupos:

    - **GRUPO I**: aquellos que presentan un riesgo para la salud pública y/o profesional, porque el fallecido padeciera una enfermedad infectocontagiosa de las que se incluyen en el anexo 3 de la presente guía y que se podrá modificar en función de la evidencia científica disponible.

    - **GRUPO II:** aquellos que presenten riesgo radiológico por la presencia en los mismos de sustancias o productos radiactivos. Para su tratamiento se estará a lo dispuesto en la normativa sobre seguridad nuclear.

    - **GRUPO III:** aquellos que no presenten los riesgos de los grupos I y II.

  - Desde el 23 marzo de 2022 los fallecidos por COVID pasan a ser parte del grupo III.
  - Cualquier persona que tenga conocimiento de la presencia de un cadáver de los grupos I y II deberá ponerlo en conocimiento inmediato de Salud Pública a través del CCU.

- Si el cadáver va a ser incinerado debe tenerse en cuenta la presencia de marcapasos por la posibilidad de explosión de la pila, también si ha estado tratado con isótopos radiactivos o porta alguna prótesis.
- La información del Boletín Estadístico de Defunción debe ser rellenada por los familiares, empleados de la funeraria o, en su defecto, por el encargado del Registro Civil.

En el anexo 2 aparece un resumen para la adecuada cumplimentación del CMD.

En el anexo 3 aparece la clasificación de los cadáveres en función de la causa de defunción (grupo I, II y III).

En la emisión de CMD NO ES EXIGIBLE LA CERTEZA ABSOLUTA del facultativo en cuanto a la determinación de las causas del fallecimiento, siempre que se entiendan dichas causas como naturales.

No existirá responsabilidad si hubiese un error de diagnóstico, aunque haya ocasionado daño a terceros, siempre que se actúe conforme a la *lex artis*. La responsabilidad penal vendría por la falta de exactitud o veracidad en la cumplimentación del CMD, pudiendo además generar responsabilidad civil, un ejemplo claro es el de alterar la hora de la muerte a petición de la familia para agilizar los trámites administrativos.

En caso de que el facultativo no haya podido determinar la causa de la muerte y la familia esté de acuerdo, se puede solicitar una autopsia clínica, pues se trata de un recurso que puede aportar información relevante para el ámbito sanitario. Para ello hace falta la autorización de la familia y el Certificado Médico de Defunción. Se rige por la Ley 29/1980, de 21 junio, de autopsias clínicas.

Si los familiares o allegados del fallecido plantean dudas sobre la causa concreta de muerte natural manifestada por el médico, los familiares deberán ponerlo en conocimiento del Juzgado de Guardia.

En caso de duda o necesidad de consulta, este procedimiento contempla la posibilidad de comunicación directa con el médico forense de guardia y viceversa a través del CCU.

6.1. PROTOCOLO ENTREGA CMD CUMPLIMENTADO POR EL MEDICO DE URGENCIAS O EMERGENCIAS

El certificado que cumplimentará el médico de Urgencias o Emergencias extrahospitalarias, ya sea del 061 u otros como PAC/PEA, será entregado a los servicios funerarios en el domicilio si tiene la información suficiente para poder hacerlo o en la base de la unidad si precisa consultar informes médicos de la persona fallecida (Agoraplus).

Estas unidades tendrán 5 certificados médicos, que serán aportados por los servicios funerarios, para agilizar la cumplimentación de este.

Los servicios funerarios retirarán el certificado cumplimentado y entregarán un certificado nuevo (mismo sistema que utilizan los servicios funerarios en los centros hospitalarios) con la mayor brevedad posible.

No se entregarán certificados cumplimentados sin la entrega del certificado nuevo, al finalizar el turno del equipo sanitario, la ambulancia deberá contar con los 5 certificados médicos con la que empezó el turno.

Los certificados médicos que contengan errores que no hayan podido ser subsanados, se entregarán a los servicios funerarios para ser repuestos por el colegio de médicos.

ANEXO 1

IMPRESO DEL CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCIÓN (CMD/BED)

OMC — ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA | CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS

CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN

https://certificados.cgcom.es
EDLLLTO5ZA
Id. Electrónico

Colegio de ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS MURCIA

036353508
Nº Certificado

CLASE 3ª SERIE A

3,63 Euros. Derechos autorizados, I.V.A. incluido

D. / Dña. _____

en Medicina y Cirugía, colegiado/a en _____, con el número

y con ejercicio profesional en _____

CERTIFICO la defunción de

Nombre del fallecido/a:

1er Apellido del fallecido/a:

2º Apellido del fallecido/a:

Fecha de nacimiento Día Mes Año **Sexo:** Varón Mujer

Documento de identidad: D.N.I. Número: — Pasaporte Número: N.I.E. (Tarjeta de Residencia) Número: —

Hora y fecha de la defunción Hora : minutos : Día Mes Año

¿En qué municipio ocurrió la defunción?: _____

Domicilio particular Centro hospitalario Residencia socio-sanitaria Lugar de trabajo Otro lugar

Causas de defunción (ver instrucciones en página 2) — **Intervalo de tiempo aproximado**[1]

I. Causa inmediata[2]
(a) Horas Días Meses Años

Debido a

Causas intermedias[3]
(b) Horas Días Meses Años

Debido a

(c) Horas Días Meses Años

Debido a

Causa inicial o fundamental[4]
(d) Horas Días Meses Años

II. Otros procesos[5]
Horas Días Meses Años

¿Ha habido indicios de muerte violenta? Sí No

¿Se practicó autopsia clínica? Sí No

¿La defunción ha ocurrido como consecuencia directa o indirecta de?:

Accidente de tráfico No Sí Accidente laboral No Sí Fecha del mismo: Día Mes Año

Continúa al reverso

Mod. CMD-BED-IVA 1 2 3 4 5 (ver instrucciones en página 2) 01

¿Existen riesgos infecciosos?

Sí ☐ No ☐

Enfermedad infecciosa _____

Grupo: I ☐ II ☐ III ☐

¿Posibilidad de incineración?

Sí ☐ No ☐

Incineración condicionada por:

☐ **Retirada de Marcapasos**

☐ **Tratamiento con Isótopos Radioactivos**

☐ **Existencia de prótesis**

En _____, a _____ de _____ de _____

Firma del médico

Instrucciones básicas de Certificación:

La OMS recomienda que en la cumplimentación de las causas de defunción se comience por la **causa inmediata** y se termine por la causa **inicial o fundamental**, es decir, en un orden natural de arriba hacia abajo, respondiendo a las palabras **"debido a"** que facilitan la comprensión del concepto de **secuencia lógica**, tan importante para la selección de la Causa Básica de Defunción.

Causa básica de defunción: "Enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal".

1 Intervalo de tiempo aproximado

Anotar el tiempo transcurrido entre el comienzo de cada afección y el momento de la defunción, de tal forma que el tiempo anotado en el apartado I.(a) debe ser inferior o igual a I.(b), y éste a su vez inferior o igual al I.(c) y así sucesivamente.

Estas unidades son mutuamente excluyentes, es decir, hay que expresar el período en una única unidad de tiempo y tan solo hay que rellenar una por proceso y línea. Si hubiera que anotar más de un proceso en una línea, el tiempo anotado debe corresponder al primer proceso informado (el más importante).

Nota: Cada unidad de tiempo admite hasta el número 99.

Ejemplo:

Para mes y medio, anotar 45 días — Horas ☐☐ Días 4 5 Meses ☐☐ Años ☐☐

I

2 Causa inmediata:

(a) Indicar la enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente. No se trata de indicar las modalidades de la muerte, sino la enfermedad, el traumatismo o la complicación causante del fallecimiento.

Ejemplo: (a) Hemorragia cerebral — Horas 3 ☐ Días ☐☐ Meses ☐☐ Años ☐☐

debido a ↓

3 Causas intermedias:

(b) y (c) Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba indicada.

Si el estado patológico señalado en la línea (a) fue consecuencia de uno o más estados morbosos, se anotarán en la línea (b) o en las líneas (b) y (c).

Ejemplo: (b) Hipertensión arterial — Horas ☐☐ Días ☐☐ Meses ☐☐ Años ☐2

debido a ↓

(c) Pielonefritis crónica — Horas ☐☐ Días ☐☐ Meses ☐☐ Años ☐2

debido a ↓

4 Causa inicial o fundamental:

(d) Enfermedad o lesión que inició los hechos anteriormente mencionados que condujeron a la muerte. Se anotará una única causa, la que haya sido desencadenante de todo el proceso que ha llevado a la defunción. En caso de accidente o violencia, se hará una breve descripción de las circunstancias.

Ejemplo: (d) Adenoma prostático — Horas ☐☐ Días ☐☐ Meses ☐☐ Años ☐5

II

5 Otros procesos:

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado patológico que la produjo.

Ejemplo: Diabetes — Horas ☐☐ Días ☐☐ Meses ☐☐ Años 1 0

Otras recomendaciones

1.Utilizar mayúsculas y preferentemente bolígrafo de tinta negra.

2.Evitar abreviaturas y/o siglas.

3.Certificar enfermedades y síndromes sin ambigüedades.

4.Si fuera preciso anotar más de una enfermedad en cada apartado, sepárelas claramente por comas.

5.Evitar certificar entidades mal definidas, signos y síntomas.

Nota: Las dos líneas de cuadrados previstas para cada apartado deben considerarse como una sola y no para establecer orden de causalidad.

Mod. CMD-BED-IVA ☐☐☐☐■☐ ☐■ 02

ANEXO 2

RESUMEN PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCIÓN

Principios para tener en cuenta al certificar una defunción y al rellenar el Certificado Médico de Defunción / Boletín Estadístico de Defunción (CMD/BED):

1. Inspeccionar al cadáver.
2. Utilizar información real.
3. Evitar abreviaturas que se presten a confusión.
4. Describir la secuencia lógica y temporal de las patologías a la muerte.
5. Certificar enfermedades y síndromes sin ambigüedades.
6. No certificar signos y síntomas.
7. Evitar certificar mecanismos de muerte.
8. Cumplimentar por el médico el CMD/BED especialmente el apartado Causa de la Defunción.

*** PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR:**

AUTOFORMACIÓN MÉDICA EN CERTIFICACIÓN DE LA DEFUNCIÓN.

http://www.murciasalud.es/certifica

ANEXO 3

CLASIFICACIÓN DE LOS CADÁVERES EN FUNCIÓN DE LA CAUSA DE DEFUNCIÓN

CADÁVERES GRUPO I

1. Carbunco
2. Difteria respiratoria
3. Enfermedades potencialmente transmisibles, de origen conocido o desconocido, que puedan transmitirse de persona a persona y supongan riesgo relevante para la salud pública
4. Fiebres Hemorrágicas Víricas (por arbovirus, arenavirus, bunyavirus, filovirus, flavivirus, hantavirus y otros), así como Fiebres Hemorrágicas de origen desconocido
5. Fiebre Q
6. Peste neumónica
7. Viruela
8. Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas

CADÁVERES GRUPO II

Cadáveres contaminados por sustancias radioactivas.

CADÁVERES GRUPO III

Cadáveres que no pertenezcan a ninguno de los dos grupos anteriores.